

1. La maladie athérothrombotique est responsable de plus de 90% des artériopathies.	1. Vrai
2. Les artériopathies non athéromateuses ne touchent que les artères des membres inférieurs.	2. Faux
3. Les causes emboligènes des artériopathies sont très nombreuses : thrombus, valvulopathies, troubles du rythme (FA), aortite ulcérée, anévrysme de l'aorte, sténose emboligène, myxome, embolies de cholestérol,...	3. Vrai
4. Les embolies paradoxales débutent souvent à partir d'une TVP des membres supérieurs.	4. Faux
5. L'embolie paradoxale est caractérisée par le passage d'un embolus à travers un foramen ovale perméable.	5. Vrai
6. Les artériopathies non athéromateuses ne touchent jamais l'aorte ou les vaisseaux à destination encéphalique.	6. Faux
7. Les embolies du membre supérieur peuvent être associées à un syndrome du défilé thoracique.	7. Vrai
8. Le syndrome de la poplitée piégée affecte principalement les personnes âgées.	8. Faux
9. Les kystes adventiciels sont responsables d'une obstruction progressive de la lumière artérielle.	9. Vrai
10. Les dysplasies fibromusculaires touchent principalement les artères fémorales superficielles.	10. Faux
11. L'endofibrose iliaque externe touche le plus souvent les personnes sédentaires.	11. Faux
12. L'artérite post-radique survient généralement plusieurs années après une radiothérapie anti-cancéreuse.	12. Vrai

13. Les artériopathies toxiques sont principalement causées par l'exposition à des métaux lourds.	13. Faux
14. Le pseudoxanthome élastique affecte principalement les hommes.	14. Faux
15. Les embolies paradoxales se produisent souvent à partir d'une TVP des membres inférieurs.	15. Vrai
16. La dysplasie fibromusculaire touche principalement les artères rénales, les carotides et les artères iliaques.	16. Vrai
17. L'endofibrose iliaque externe est spécifique aux personnes âgées.	17. Faux
18. Seulement 10% des artériopathies ne sont pas causées par la maladie athérombotique.	18. Vrai
19. Les artériopathies non athéromateuses ne touchent pas uniquement les artères des membres inférieurs.	19. Vrai
20. Le syndrome de la poplitée piégée est une cause d'artériopathie athéromateuse.	20. Faux
21. Le syndrome de la poplitée piégée est caractérisé par une claudication intermittente chez les sujets jeunes sans facteurs de risque d'athérosclérose.	21. Vrai
22. L'ischémie mésentérique aiguë est une manifestation courante de la maladie kystique adventicielle.	22. Faux
23. Les dysplasies fibromusculaires touchent préférentiellement les hommes.	23. Faux
24. La dysplasie fibromusculaire peuvent causer une hypertension artérielle en cas d'atteinte des artères rénales.	24. Vrai
25. Les endofibroses iliaques externes sont spécifiques des sujets sportifs.	25. Vrai
26. Les endofibroses iliaques externes entraînent généralement une claudication basse.	26. Faux

27. Les dissections artérielles touchent surtout l'aorte et peuvent s'étendre vers les carotides ou les artères du MI.	27. Vrai
28. Certains médicaments anti-migraineux contiennent des dérivés de l'ergot de seigle.	28. Vrai
29. La maladie de Buerger touche principalement les femmes.	29. Faux
30. La maladie de Buerger est associée à un risque accru de thrombophlébites superficielles migrantes.	30. Vrai
31. La maladie de Horton affecte principalement les jeunes adultes.	31. Faux
32. La maladie de Horton est également appelée artérite à cellules géantes.	32. Vrai
33. La maladie de Takayasu affecte principalement les hommes.	33. Faux
34. La maladie de Takayasu touche principalement les artères de gros et moyen calibre.	34. Vrai
35. La maladie de Takayasu est plus fréquente en Europe occidentale qu'en Orient.	35. Faux
36. La maladie de Behçet est caractérisée par des ulcérations buccales et génitales récurrentes.	36. Vrai
37. Les artères sont les seules structures vasculaires touchées par la maladie de Behçet.	37. Faux
38. Les kystes adventiciels peuvent provoquer une claudication intermittente chez les sujets jeunes.	38. Vrai
39. Les dysplasies fibromusculaires touchent principalement les artères coronaires.	39. Faux
40. Le pseudoxanthome élastique est une maladie non héréditaire du tissu conjonctif.	40. Faux
41. Les artérites inflammatoires n'affectent que les gros vaisseaux.	41. Faux

42. La maladie de Buerger est plus fréquente chez les hommes jeunes de <40 ans et fumeurs.	42. Vrai
43. La maladie de Behçet n'entraîne pas de manifestations cutanées.	43. Faux
44. Les embolies de cholestérol sont un exemple de cause emboligène d'artériopathies non athéromateuses.	44. Vrai
45. Le syndrome du défilé thoraco-brachial est associé à des emboles dans les membres inférieurs.	45. Faux
46. Le syndrome de la poplitée piégée est souvent associé à une douleur du membre inférieur au repos.	46. Faux
47. Les maladies kystiques adventicielles affectent souvent les artères poplitées.	47. Vrai
48. Les artérites post-radique surviennent généralement dans un territoire irradié.	48. Vrai
49. L'ergot de seigle provoque une vasoconstriction centrale et des effets hallucinogènes.	49. Faux
50. Le pseudoxanthome élastique affecte principalement la peau, la rétine et les parois artérielles.	50. Vrai
51. La maladie de Buerger est associée à un risque accru de maladies cardiaques.	51. Faux
52. La maladie de Takayasu touche principalement les artères des membres inférieurs.	52. Faux
53. La maladie de Behçet provoque souvent une atteinte oculaire (iritis, uvéite, conjonctivite,...).	53. Vrai
54. Les artérites post-radiques affectent principalement les artères iliaques et carotides.	54. Vrai
55. Les artériopathies toxiques sont principalement causées par des toxines alimentaires.	55. Faux
56. Le pseudoxanthome élastique est une maladie rare à prédominance féminine.	56. Vrai

57. Les artérites inflammatoires touchent uniquement les vaisseaux de petit calibre.	57. Faux
58. La maladie de Horton est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.	58. Faux
59. Les ulcérations buccales ou génitales sont un critère diagnostique de la maladie de Behçet.	59. Vrai
60. La thromboangéite oblitérante est une maladie vasculaire non inflammatoire.	60. Faux
61. La prévalence de la maladie de Buerger est plus élevée en Asie et en Europe centrale.	61. Vrai
62. La maladie de Horton affecte les branches de la carotide externe mais pas celles de la carotide interne.	62. Faux
63. La fièvre est un symptôme courant de la maladie de Horton.	63. Vrai
64. La maladie de Horton touche quasi exclusivement les personnes âgées de plus de 60 ans.	64. Vrai
65. L'inflammation de la maladie de Horton est traitée par corticoïdes car les AINS sont souvent insuffisants.	65. Vrai
66. Les artères sous-clavières sont rarement affectées dans la maladie de Takayasu.	66. Faux
67. La maladie de Behçet est souvent plus sévère chez les femmes.	67. Faux
68. La maladie de Behçet débute souvent après 55 ans.	68. Faux
69. La biopsie est souvent nécessaire pour confirmer le diagnostic de la maladie de Behçet.	69. Faux
70. Les corticoïdes sont utilisés dans le traitement des formes graves de la maladie de Behçet.	70. Vrai
71. Les anticoagulants sont utilisés en cas de thrombose veineuse profonde dans la maladie de Behçet.	71. Vrai

72. La maladie de Buerger touche exclusivement les artères des membres supérieurs et inférieurs.	72. Faux
73. La maladie de Takayasu est fréquemment associée à une pseudo-polyarthrite rhizomélitique.	73. Faux
74. La maladie de Takayasu est plus fréquente chez les femmes jeunes.	74. Vrai
75. Les pouls périphériques sont généralement conservés dans la maladie de Takayasu.	75. Faux
76. La maladie de Takayasu est plus fréquente en Orient et sur le pourtour méditerranéen.	76. Vrai
77. Les lésions cutanées sont un critère nécessaire pour le diagnostic de la maladie de Behçet.	77. Vrai
78. La maladie de Buerger est souvent associée à un phénomène de Raynaud.	78. Vrai
79. Les pouls périphériques sont souvent absents dans la maladie de Takayasu.	79. Vrai
80. La maladie de Buerger est associée à une prédisposition génétique au niveau du groupe HLA.	80. Vrai
81. Les manifestations oculaires sont absentes dans la maladie de Horton.	81. Faux
82. Les manifestations cutanées sont un critère majeur pour le diagnostic de la maladie de Behçet.	82. Faux
83. Le syndrome de la poplitée piégée est dû à des anomalies d'insertion musculo-tendineuses qui gênent le passage du sang par compression de la veine poplitée lors de certains mouvements.	83. Faux
84. L'artère poplitée peut être comprimée de façon continue par des muscles ou des tendons du creux poplité.	84. Faux
85. Le syndrome de la poplitée piégée est caractérisé par une claudication intermittente chez les sujets âgés.	85. Faux

86. Le syndrome de la poplitée piégée provoque une insuffisance circulatoire artérielle lors de la flexion de la jambe et de la dorsiflexion du pied.	86. Faux
87. Le syndrome de la poplitée piégée est diagnostiqué par une disparition des pouls à la dorsiflexion du pied.	87. Vrai
88. L'artériographie dynamique permet de visualiser la compression poplitée lors de certains mouvements.	88. Vrai
89. L'artériographie statique est inutile dans le diagnostic du syndrome de la poplitée piégée.	89. Faux
90. L'échographie permet de visualiser les anomalies d'insertion des structures musculo-tendineuses en cas de syndrome de la poplitée piégée.	90. Faux
91. La RMN est utilisée dans le diagnostic du syndrome de la poplitée piégée.	91. Vrai
92. Les maladies kystiques adventitielles affectent principalement les artères fémorales profondes.	92. Faux
93. La maladie kystique adventitielle est due à une dégénérescence kystique ou mucoïde de la paroi artérielle.	93. Vrai
94. La maladie kystique adventitielle entraîne une ischémie du membre supérieur en aval du kyste.	94. Faux
95. La maladie kystique adventitielle entraîne une claudication intermittente persistante du sujet d'âge moyen.	95. Faux
96. Les kystes adventitiels se remplissent progressivement de mucus et obstruent la lumière artérielle.	96. Vrai
97. Les kystes adventitiels se vident habituellement dans la lumière veineuse par une fistule artério-veineuse.	97. Faux
98. La vidange du kyste adventitiel normalise le flux artériel et fait disparaître la claudication.	98. Vrai

99. Le diagnostic de la maladie kystique adventitielle est basé sur la clinique, l'échographie, le CT-scan et la RMN.	99. Vrai
100. La dysplasie fibrokystique touche 8 fois plus souvent les femmes que les hommes.	100. Vrai
101. La dysplasie fibrokystique entraîne toujours une fibrose de la limitante élastique interne.	101. Faux
102. La dysplasie fibrokystique se manifeste par un aspect typique « en collier de perles » à l'angiographie.	102. Vrai
103. La dysplasie fibrokystique ne touche que la média des artères.	103. Faux
104. La forme la plus fréquente de dysplasie fibrokystique provoque une hyperplasie de la média.	104. Vrai
105. La dysplasie fibrokystique est une cause d'HTA rénovasculaire.	105. Vrai
106. La dysplasie fibrokystique carotidienne peut entraîner un AVC, une dissection ou un anévrisme.	106. Vrai
107. L'endofibrose iliaque externe est spécifique de l'haltérophile de haut niveau.	107. Faux
108. L'endofibrose iliaque externe est caractérisée par une sténose artérielle due aux frottements répétés.	108. Vrai
109. L'endofibrose iliaque du cycliste de haut niveau siège au niveau de l'artère iliaque interne dans 90% des cas.	109. Faux
110. L'endofibrose iliaque externe est caractérisée par des lésions intimaux fibreuses et multi-cellulaires.	110. Faux
111. L'endofibrose iliaque externe provoque une fibrose de l'intima avec une oblitération artérielle progressive.	111. Vrai
112. Les symptômes de l'endofibrose iliaque externe peuvent survenir au repos.	112. Faux
113. L'artérite post-radique se manifeste par une clinique similaire à celle de l'AOMI.	113. Vrai

114. La chirurgie est le traitement de référence pour l'artérite post-radique.	114. Faux
115. Le traitement de l'artérite post-radique est de préférence conservateur ou endovasculaire.	115. Vrai
116. L'artérite post-radique survient généralement quelques mois après une radiothérapie anti-cancéreuse.	116. Faux
117. Toutes les artères sont susceptibles de subir un traumatisme.	117. Vrai
118. Le traumatisme artériel le plus fréquent est la rupture de l'aorte abdominale.	118. Faux
119. Un traumatisme thoracique non ouvert à grande vitesse peut induire une rupture de la valve aortique.	119. Faux
120. La rupture de l'aorte thoracique est liée dans 80 à 90% des cas à un accident sur la voie publique.	120. Vrai
121. La rupture de l'aorte thoracique peut survenir suite à une chute d'une hauteur élevé (accident de travail, accidents d'avion, défenestrations,...).	121. Vrai
122. La dissection aortique est une déchirure le plus souvent transversale de l'intima.	122. Faux
123. La déchirure circonférentielle de l'intima induit la formation d'une vraie et d'une fausse lumière.	123. Vrai
124. Les dissections aortiques n'entraînent jamais de symptômes périphériques.	124. Faux
125. Le 1 ^{er} trimestre de la grossesse est une période à risque de dissections artérielles.	125. Faux
126. L'HTA est un facteur prédisposant dans 70% des dissections artérielles.	126. Vrai
127. Le traitement est le même pour tous les types de dissections artérielles.	127. Faux

128. La médianécrose kystique, les maladies des lames élastiques et du collagène (Marfan, Ehlers-Danlos,...) et les anomalies congénitales de la valve aortique sont des facteurs prédisposants aux dissections artérielles.	128. Vrai
129. Certains toxiques peuvent léser les artères ou occasionner un vasospasme artériel.	129. Vrai
130. L'ergot de seigle est une bactérie parasite des céréales comme le seigle et le blé.	130. Faux
131. L'ergot de seigle contient des alcaloïdes dérivés de l'acide arachidonique.	131. Faux
132. L'ergotisme n'est jamais causé par des médicaments anti-migraineux.	132. Faux
133. L'ergotisme induit des spasmes artériels périphériques fluctuants avec des symptômes d'ischémie périphérique et est une cause d'artériopathies toxiques.	133. Vrai
134. Le pseudoxanthome élastique induit une calcification et un allongement progressif des fibres élastiques.	134. Faux
135. La prévalence du pseudoxanthome élastique varie entre 1/25 000 et 1/100 000.	135. Vrai
136. Le pseudoxanthome élastique nécessite très souvent une amputation des extrémités des membres.	136. Faux
137. Les calcifications artérielles sont responsables d'une artériosclérose précoce en cas de pseudoxanthome élastique.	137. Vrai
138. Le pseudoxanthome élastique se manifeste par une claudication intermittente, des papules cutanées rougeâtres, des excès de peau et un aspect de peau d'orange.	138. Vrai

139. Le pseudoxanthome élastique ne conduit jamais à la cécité.	139. Faux
140. Le pseudoxanthome élastique induit des hémorragies digestives dans 50% des cas.	140. Vrai
141. Le fond d'œil montre des stries angioïdes à partir de la papille en cas de pseudoxanthome élastique.	141. Vrai
142. Les stries angioïdes sont des craquelures/déchirures sombres de la membrane de Bruch qui entraînent l'émergence de néovaisseaux en provenance de la choroïde.	142. Vrai
143. L'aspirine est utilisée dans le traitement du pseudoxanthome élastique.	143. Faux
144. La fragmentation des fibres élastiques des vaisseaux entraîne une multitude de complications thrombotiques en cas de pseudoxanthome élastique.	144. Faux
145. La thromboangéite oblitérante atteint les artères distales de grand calibre >3mm.	145. Faux
146. La maladie de Buerger constitue 0,5 à 5% des artériopathies des membres inférieurs.	146. Vrai
147. La thromboangéite oblitérante atteint exclusivement les artères et les veines des membres inférieurs.	147. Faux
148. Le tabac est un facteur protecteur contre la maladie de Buerger.	148. Faux
149. La maladie de Buerger est associée à la consommation de tabac et probablement de cannabis.	149. Vrai
150. La maladie de Buerger est fréquemment caractérisée par une triade associant claudication du membre atteint, phénomène de Raynaud et thrombophlébites profondes migrantes.	150. Faux

151. La maladie de Buerger évolue par poussées suivies de périodes de rémissions.	151. Vrai
152. L'artériographie montre des collatérales spiralées « en tire-bouchon » dans la maladie de Buerger.	152. Vrai
153. Le test d'Allen est inutile dans le diagnostic de la thromboangéite oblitérante.	153. Faux
154. La biologie montre souvent des signes très spécifiques en cas de maladie de Buerger.	154. Faux
155. La biopsie est rarement possible dans la maladie de Buerger sauf en cas de TVS.	155. Vrai
156. La biopsie montre une panvascularite avec thrombus frais hypercellulaire comprenant des polynucléaires neutrophiles, des macrophages et des cellules multinuclées en cas de maladie de Buerger.	156. Vrai
157. L'arrêt du tabac est un élément salvateur en cas de thromboangéite oblitérante.	157. Vrai
158. Les bêta-bloquants font partie du traitement de la maladie de Buerger.	158. Faux
159. Le traitement de la thromboangéite oblitérante comprend des antiagrégants plaquettaires, des anticoagulants, des antagonistes calciques et de la prostacycline (iloprost).	159. Vrai
160. La chirurgie de revascularisation est un traitement de choix dans la maladie de Buerger.	160. Faux
161. Certains cas de maladie de Buerger peuvent bénéficier d'une sympathectomie.	161. Vrai
162. Des amputations limitées sont parfois nécessaires en cas de maladie de Buerger.	162. Vrai
163. L'artérite à cellules géantes prédomine au niveau de l'intima en cas de maladie de Horton.	163. Faux

164.	La maladie de Horton provoque une atteinte vasculaire de topographie segmentaire et unifocale.	164. Faux
165.	La maladie de Horton touche préférentiellement l'aorte et ses branches de division.	165. Vrai
166.	La maladie de Horton touche uniquement les branches de la carotide interne : temporale, ophtalmique,...	166. Faux
167.	La maladie de Horton est associée à des douleurs scapulaires et des hanches en fin de journée.	167. Faux
168.	La maladie de Horton touche environ 100 habitants de plus de 50 ans sur 100 000.	168. Faux
169.	La maladie de Horton provoque des céphalées dans 65 à 70% des cas.	169. Vrai
170.	La maladie de Horton est fréquemment associée à une pseudo-polyarthrite rhizomélitique.	170. Vrai
171.	La maladie de Horton touche surtout les vaisseaux terminaux de petit calibre.	171. Faux
172.	La maladie de Buerger touche les artères distales de petit et moyen calibre de 1 à 3mm.	172. Vrai
173.	La maladie de Horton est plus fréquente chez la femme.	173. Vrai
174.	La maladie de Horton est plus fréquente dans les populations blanches d'Europe et d'Amérique du Nord.	174. Vrai
175.	La maladie de Horton est une cause potentielle de cécité chez le sujet jeune.	175. Faux
176.	Le soleil, l'environnement et la prédisposition génétique jouent probablement un rôle dans la survenue de la maladie de Horton.	176. Vrai
177.	Les temporales sont douloureuses à la palpation dans la majorité des cas d'artérite à cellules géantes.	177. Faux

178. La maladie de Horton se manifeste par de la fièvre et de l'asthénie sans altération de l'état général.	178. Faux
179. La pseudo-polyarthrite rhizomélique se manifeste par une raideur des ceintures scapulaires et pelviennes.	179. Vrai
180. L'amaurose fugace, la claudication massétérine, les artères temporales douloureuses à la palpation et les paresthésies du cuir chevelu sont des signes évocateurs présents chez 30-40% des cas de maladie de Horton.	180. Vrai
181. La claudication massétérine correspond à une ischémie et une crampe du masséter à la mastication.	181. Vrai
182. La vitesse de sédimentation est souvent normale en cas de maladie de Horton.	182. Faux
183. La biologie montre une anémie inflammatoire, une CRP élevée et une diminution des plaquettes dans la maladie de Horton.	183. Faux
184. La maladie de Horton est souvent associée à une cholestase biologique.	184. Vrai
185. La VS est souvent >50mm/min en cas de maladie de Horton.	185. Faux
186. L'échographie-Doppler des artères temporales permet de diagnostiquer la maladie de Horton.	186. Vrai
187. La biopsie d'une artère temporale montre des cellules monomorphes et géantes dans la média avec une rupture de la limitante élastique interne en cas de maladie de Horton.	187. Faux
188. Les AINS sont souvent suffisants pour traiter l'inflammation responsable de la maladie de Horton.	188. Faux
189. Le PET-scan est actuellement le meilleur choix pour diagnostiquer la maladie de Horton.	189. Faux

190. La maladie de Horton est traitée par une courte corticothérapie.	190. Faux
191. Le traitement de la phase aigüe de la maladie de Horton est composé de prednisone à 0,5-1mg/j pendant 3 à 6 semaines.	191. Faux
192. La corticothérapie nécessite une supplémentation en vitamine D et en calcium chez le sujet âgé.	192. Vrai
193. La corticothérapie doit souvent être poursuivie à des doses d'entretien (5-10mg/j) pendant 1 à 2 ans en cas de maladie de Horton.	193. Vrai
194. La corticothérapie prolongée permet de minimiser le risque de rechute de la maladie de Horton.	194. Vrai
195. La maladie de Takayasu est aussi appelée maladie des hommes sans pouls.	195. Faux
196. Tous les gros vaisseaux peuvent être atteints par la maladie de Takayasu.	196. Vrai
197. La maladie de Takayasu est une artérite inflammatoire et thrombosante du sujet jeune.	197. Faux
198. La maladie de Takayasu est une artérite de l'aorte et ses branches à prédominance médio-adventitielle.	198. Vrai
199. La maladie de Takayasu atteint préférentiellement l'aorte ascendante et les artères sous-clavières.	199. Faux
200. On ne retrouve généralement pas de cellules géantes dans la maladie de Takayasu.	200. Faux
201. La crosse de l'aorte est très souvent atteinte par la maladie de Takayasu.	201. Vrai
202. La maladie de Takayasu débute fréquemment à l'adolescence ou avant 20 ans.	202. Vrai

203. La maladie de Takayasu touche 1 à 2,5 cas/100 000 habitants par an en Europe occidentale.	203. Faux
204. La maladie de Takayasu est parfois associée à une maladie de Crohn ou à une spondylarthrite ankylosante.	204. Vrai
205. La maladie de Takayasu est probablement causée par des mécanismes immunopathogéniques.	205. Vrai
206. La maladie de Takayasu est caractérisée par un infiltrat de cellules géantes plurinucléées à prédominance médio-adventitielle.	206. Faux
207. La tension artérielle est souvent très élevée en cas de maladie de Takayasu.	207. Faux
208. Les symptômes généraux (malaises, fièvre, transpiration nocturne, arthralgies, anorexie, amaigrissement,...) surviennent souvent après l'atteinte vasculaire en cas de maladie de Takayasu.	208. Faux
209. Les pouls peuvent être abolis par une atteinte des artères sous-clavières par la maladie de Takayasu.	209. Vrai
210. Les signes généraux précèdent souvent de plusieurs mois la phase vasculaire de la maladie de Takayasu.	210. Vrai
211. L'érythème noueux survient préférentiellement sur la partie pré-tibiale des membres inférieurs.	211. Vrai
212. La maladie de Takayasu peut provoquer une HTA en cas d'atteinte des artères rénales.	212. Vrai
213. La maladie de Takayasu est toujours d'évolution progressive et relativement stable.	213. Faux
214. La biologie est très spécifique de la maladie de Takayasu.	214. Faux
215. La maladie de Takayasu se manifeste par une VS parfois augmentée, des Ig augmentés et une anémie.	215. Vrai

216.	L'échographie n'est pas utilisée dans le diagnostic de la maladie de Takayasu.	216. Faux
217.	L'artériographie et l'angioscanner renseignent sur la lumière artérielle en cas de maladie de Takayasu.	217. Vrai
218.	Le PET-scan est le meilleur moyen de diagnostiquer une maladie de Takayasu.	218. Vrai
219.	Des biopsies sont fréquemment réalisées pour confirmer le diagnostic de la maladie de Takayasu.	219. Faux
220.	La revascularisation chirurgicale ou endovasculaire est souvent impossible en cas de maladie de Takayasu.	220. Faux
221.	Le traitement de la maladie de Takayasu comprend des corticoïdes et des immunosuppresseurs.	221. Vrai
222.	Les immunosuppresseurs sont parfois utiles dans le traitement de la maladie de Horton.	222. Faux
223.	La maladie de Behçet est associée à des manifestations articulaires, nerveuses et cutanées.	223. Vrai
224.	Le substratum est une vascularite des gros et des moyens vaisseaux artériels ou veineux.	224. Faux
225.	La maladie de Behçet débute souvent entre 18 et 40 ans.	225. Vrai
226.	Il existe des formes familiales de la maladie de Behçet.	226. Vrai
227.	La présence d'aphtes buccaux ou génitaux récidivants est nécessaire au diagnostic de la TAO.	227. Faux
228.	Le test pathergique montre une hypersensibilité au point de piqure chez le sujet sain.	228. Faux
229.	Des arthrites non déformantes sont associées à la maladie de Behçet dans 25% des cas.	229. Vrai
230.	La maladie de Behçet peut provoquer une folliculite, un érythème noueux et de l'acné sévère.	230. Vrai

231.	La névrite optique est associée à la maladie de Horton mais pas à la maladie de Behçet.	231. Faux
232.	La maladie de Behçet provoque des thromboses veineuses du membre inférieur dans la majorité des cas.	232. Faux
233.	La maladie de Behçet peut rarement causer des anévrysmes ou des thromboses artérielles.	233. Vrai
234.	La maladie de Behçet est plus fréquente en Asie et autour du Bassin méditerranéen.	234. Faux
235.	L'atteinte digestive est peu fréquente dans la maladie de Behçet.	235. Vrai
236.	La maladie de Behçet ne touche jamais le système nerveux central.	236. Faux
237.	L'érythème noueux est caractérisée par de multiples nodules sous-cutanées rouges, chauds et sensibles.	237. Vrai
238.	Plus de 3 épisodes d'ulcérations orales en 12 mois peuvent faire suspecter une maladie de Behçet.	238. Vrai
239.	La capillaroscopie montre une microvascularite épidermique dans 60% des cas de maladie de Behçet.	239. Faux
240.	La maladie de Behçet augmente le risque de formation anévrysmale au point de ponction en cas d'artériographie ou d'autre acte invasif.	240. Vrai
241.	La colchicine est utilisée dans le traitement des formes graves de maladie de Behçet.	241. Faux
242.	Toutes les thromboses artérielles liées à la maladie de Behçet doivent être traitées en endovasculaire.	242. Faux
243.	La corticothérapie est utilisée dans le traitement des formes graves de maladie de Behçet.	243. Vrai
244.	Le méthotrexate est utilisée dans le traitement des formes cutanéomuqueuses de la maladie de Behçet.	244. Faux

245. L'azathioprine est utilisée dans le traitement des formes graves de maladie de Behçet.	245. Vrai
246. Les anévrysmes artériels liés à la maladie de Behçet doivent impérativement être traités par chirurgie.	246. Vrai
247. Le test de pathergie montre une pustule stérile après 24h en cas de maladie de Behçet.	247. Faux
248. Les anévrysmes artériels liés à la maladie de Behçet ont un faible risque de rupture.	248. Faux
249. L'atteinte vasculaire de la maladie de Behçet touche à la fois les artères et les veines.	249. Vrai
250. La prévalence de la maladie de Behçet est plus élevée en Turquie qu'en Belgique.	250. Vrai
251. Des atteintes cutanées multiples, des troubles psychiatriques, une panuvéite bilatérale, des arthralgies spontanément résolutive et une atteinte péri- et endo-vasculaire sont des signes de la maladie de Behçet.	251. Vrai
252. L'atteinte artérielle est symptomatique chez 30 à 50% des patients atteints de la maladie de Behçet.	252. Faux
253. Le test pathergique consiste à réaliser 2 piqûres à l'aiguille sur l'intérieur de l'avant-bras.	253. Vrai
254. L'atteinte digestive de la maladie de Behçet peut faire penser à une maladie de Crohn.	254. Vrai
255. Le traitement des thrombose artérielle liée à la maladie de Behçet est habituellement conservateur.	255. Vrai
256. L'atteinte artérielle de la maladie de Behçet peut provoquer une occlusion de l'artère pulmonaire ou des hémoptysies.	256. Vrai